

TEMA 2.15 • GINECOLOGÍA

Endometriosis

PERFIL EUNACOM 2.01.1.080

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Endometriosis

Definición y Causa

Implantación de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina (peritoneo, ovarios, tabique recto-vaginal).

Teoría más aceptada: Flujo menstrual retrógrado → células endometriales viajan por trompas hacia peritoneo/ovarios.

Factor asociado: Obstrucción del tracto de salida menstrual; uso de DIU.

Clínica — Solo 2 Síntomas

TABLA 2.15.1: SÍNTOMA VS DESCRIPCIÓN	
SÍNTOMA	DESCRIPCIÓN
Dolor	Dismenorrea secundaria progresiva + dispareunia profunda + disquecia (dolor al defecar — asociado a nódulo recto-vaginal)
Infertilidad	Causa tubo-peritoneal por adherencias

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Endometriosis NO tiene: - Alteraciones menstruales (sin hipermenorrea, sin metrorragia, sin amenorrea) - Leucorrea Solo dolor e infertilidad.

Diagnóstico

- ETV (primera línea): puede estar normal o mostrar endometrioma (quiste en "vidrio esmerilado")
- Laparoscopia (gold standard): diagnóstico definitivo + terapéutico

PERLA CLÍNICA EUNACOM

ETV normal con clínica sugerente de endometriosis → laparoscopia diagnóstica. No esperar hallazgo ecográfico para confirmar.

Tratamiento

TABLA 2.15.2: OPCIÓN VS EFECTO		
OPCIÓN	EFECTO	INDICACIÓN
Cirugía (laparoscopia)	Curativo (fulgura focos)	Elección, especialmente con infertilidad
Agonistas de GnRH	Atrofia endometrio (estrógeno-dependiente) → achica focos	Pre-operatorio en endometriosis severa
ACO	Atrofia endometrio → menos dolor	Control sintomático del dolor (aumenta infertilidad)
AINEs (ácido mefenámico)	Analgesia	Complemento sintomático
Menopausia	Cura natural	Opción expectante en mujer de mayor edad sin deseos de fertilidad

Diagnóstico Diferencial (Casos Clínicos)

TABLA 2.15.3: CASO VS DIAGNÓSTICO		
CASO	DIAGNÓSTICO	CLAVE
Dispareunia 7 días + dolor a movilización cervical + palpación anexial	PIP	Inicio agudo; signos de inflamación pélvica
Dismenorrea intensa 8+ meses + 2 años de infertilidad	Endometriosis	Cuadro crónico progresivo + infertilidad
DIU + dismenorrea + dispareunia profunda 8 meses en aumento	Endometriosis	Factores de riesgo + crónico progresivo
Dispareunia + sinusorragia + 2 meses de evolución	Cáncer de cuello uterino	Sinusorragia = patología cervical; NO endometriosis

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

La sinusorragia (sangrado durante/post-coito) en una dismenorrea sugiere **patología cervical**, no endometriosis. La endometriosis nunca tiene alteraciones del flujo menstrual ni sangrado anormal.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:
"Mujer de 28 años con dismenorrea severa (EVA 9/10) que no responde a AINEs, dispareunia profunda e infertilidad de 2 años de evolución. ¿Diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:
Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Endometriosis. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Definición y Causa
- Clínica — Solo 2 Síntomas
- Diagnóstico
- Tratamiento
- Diagnóstico Diferencial (Casos Clínicos)
- | Causa tubo-peritoneal por adherencias | ::::warning
- laparoscopia diagnóstica

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ENDOMETRIOSIS)

PREGUNTA 1

Mujer de 28 años con dismenorrea severa (EVA 9/10) que no responde a AINEs, dispareunia profunda e infertilidad de 2 años de evolución. ¿Diagnóstico más probable?

- A) Síndrome de ovario poliquístico
- B) Endometriosis
- C) Enfermedad inflamatoria pélvica crónica
- D) Miomatosis uterina
- E) Vaginismo primario

PREGUNTA 2

¿Cuál es el estándar de oro para el diagnóstico definitivo de endometriosis?

- A) Ecografía transvaginal con doppler
- B) Resonancia magnética de pelvis
- C) Laparoscopia con biopsia de lesiones
- D) Medición de CA-125 sérico
- E) Histerosalpingografía

PREGUNTA 3

Paciente con endometriosis estadio II sin deseo reproductivo actual. ¿Tratamiento de primera línea para el control del dolor?

- A) Laparoscopia inmediata para resección de lesiones
- B) Anticonceptivos hormonales combinados (píldora, parche o anillo) de forma continua
- C) Análogos de GnRH por 12 meses
- D) Histerectomía total con salpingooforectomía bilateral
- E) Ibuprofeno en la dosis máxima de forma continua

RESUMEN: ENDOMETRIOSIS

Implantación de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina (peritoneo, ovarios, tabique recto-vaginal). Teoría más aceptada: Flujo menstrual retrógrado → células endometriales viajan por trompas hacia peritoneo/ovarios. 1. ETV (primera línea): puede estar normal o mostrar endometrioma (quiste en "vidrio esmerilado") 2. Laparoscopia (gold standard): diagnóstico definitivo + terapéutico